

Comparativo das Classes que Mais Confundem

Mapeamento lado a lado das dúvidas clássicas de prova, internato e balcão farmacêutico.

Objetivo: Eliminar Erros Conceituais e Trocas Perigosas

Estrutura: Duelo Direto • Mecanismo • Diferença Crítica

Público: Estudantes de Farmácia, Enfermagem e Medicina

01. DUELO CARDIOVASCULAR: IECA VS. BRA

O PULO DO GATO CLÍNICO

Ambos atuam no Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA), mas o IECA age **na enzima** (poupando bradicinina) e o BRA age **no receptor** (sem interferir na bradicinina).

CRITÉRIO	IECA (INIBIDORES DA ECA)	BRA (BLOQUEADORES DO RECEPTOR AT ₁)
Exemplos Clássicos	Enalapril, Captopril, Ramipril (Sufixo: <i>-pril</i>)	Losartana, Valsartana, Candesartana (Sufixo: <i>-sartana</i>)
Alvo Exato	Inibe a Enzima Conversora de Angiotensina	Bloqueia competitivamente o receptor AT ₁ da Angiotensina II
Impacto na Bradicinina	Impede a degradação: Bradicinina acumula no trato respiratório	Sem efeito na quebra de bradicinina
Efeito Adverso Marcante	Tosse seca persistente (5-20%) e risco de angioedema	Tosse rara / ausente (droga de escolha na intolerância aos IECA)
Semelhanças de Alerta	Ambos causam hipercalemia e são estritamente contraindicados na gravidez (teratogênicos).	

02. DUELO DOS CANAIS DE CÁLCIO: DIHIDROPIRIDÍNICOS VS. NÃO-DIHIDROPIRIDÍNICOS

CRITÉRIO	DIHIDROPIRIDÍNICOS (DHP)	NÃO-DIHIDROPIRIDÍNICOS (NÃO-DHP)
Representantes	Anlodipino, Nifedipino, Nicardipino (Sufixo: <i>-dipina</i>)	Verapamil (Fenilalquilamina) e Diltiazem (Benzotiazepina)
Seletividade Tecidual	VASCULAR Seletividade alta para musculatura lisa arterial	CARDÍACA / MISTA Alta afinidade pelo miocárdio e nó AV
Ação na Frequência (FC)	Sem redução de FC (pode gerar taquicardia reflexa)	Cronotrópico negativo: Reduz acentuadamente a FC e condução AV
Principal Indicação	Hipertensão arterial sistêmica crônica e angina vasoespástica	Controle de ritmo/frequência em Fibrilação Atrial e taquiarritmias
Efeito Adverso Marcante	Edema maleolar periférico por vasodilatação pré-capilar	Bradicardia acentuada, piora de insuficiência cardíaca e constipação (Verapamil)

03. DUELO RENAL: DIURÉTICOS DE ALÇA VS. TIAZÍDICOS

CRITÉRIO	DIURÉTICOS DE ALÇA (FUROSEMIDA)	DIURÉTICOS TIAZÍDICOS (HIDROCLOROTIAZIDA / CLORTALIDONA)
Local de Ação Renal	Ramo ascendente espesso da Alça de Henle	Túbulo contorcido distal (TCD)
Cotransportador Inibido	Inibe o simporte $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$	Inibe o simporte Na^+/Cl^-
Potência Natriurética	ALTA POTÊNCIA (elimina até 25% do Na^+ filtrado)	POTÊNCIA MODERADA (elimina 3-5% do Na^+ filtrado)
Efeito no Cálcio Urinário	↑ Eliminação de Ca^{2+} (Hipocalcemia)	↓ Eliminação de Ca^{2+} (Poupa cálcio / Hipercalcemia)
Perfil de Aplicação	Urgências congestivas: Edema Agudo de Pulmão, IC descompensada	Controle diário ambulatorial da Hipertensão Arterial Essencial

04. DUELO INCRETÍNICO: INIBIDORES DA DPP-4 VS. AGONISTAS DE GLP-1

CRITÉRIO	INIBIDORES DE DPP-4 (GLIPTINAS)	AGONISTAS DO RECEPTOR GLP-1 (GLUTIDAS)
Fármacos Típicos	Sitagliptina, Vildagliptina, Linagliptina	Semaglutida, Liraglutida, Dulaglutida
Via de Administração	Via Oral (Comprimidos diários)	Subcutânea predominante (semanal ou diária) / Oral especial
Mecanismo	Inibe a degradação do hormônio GLP-1 endógeno (níveis fisiológicos)	Ativação direta e suprafisiológica do receptor de GLP-1
Impacto no Peso Corporal	NEUTRO NO PESO	PERDA DE PESO SUBSTANCIAL (retardo do esvaziamento gástrico e saciedade central)
Proteção Cardiovascular	Segurança comprovada (efeito neutro)	Redução demonstrada de eventos cardiovasculares maiores (MACE)

05. DUELO ANTITROMBÓTICO: HNF VS. HBPM (ENOXAPARINA)

CRITÉRIO	HEPARINA NÃO FRACIONADA (HNF)	HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR (HBPM / ENOXAPARINA)
Alvo na Coagulação	Inibe igualmente Trombina (Fator IIa) e Fator Xa (1:1)	Inibe preferencialmente o Fator Xa (relação 3:1 ou 4:1 com IIa)
Monitoramento Laboratorial	Obrigatório via TTPA (tempo de tromboplastina parcial)	Normalmente desnecessário (previsível); Anti-Xa se obesos/DRC
Via e Meia-Vida	Endovenosa contínua / SC; meia-vida curta (1 a 2 horas)	Subcutânea 1-2x/dia; meia-vida longa (4 a 6 horas)
Reversão por Protamina	Reversão 100% completa por Sulfato de Protamina	Reversão parcial (apenas ~60% da atividade anti-Xa)
Risco de TIH (Plaquetopenia)	Maior risco de Trombocitopenia Induzida por Heparina	Menor risco de TIH

Material Didático Integrante do Combo Farmacologia Descomplicada
Uso exclusivo para fins didáticos e consolidação de raciocínio clínico. Atualizado segundo consensos terapêuticos vigentes.